Júlia Campa, Sara López, Lucía Quintanilla, Idoia Ruíz
16/02/2026
Anàlisi Qualitativa

TREBALL - 16 de febrer

1. Resum

En la nostra investigació, farem una observació etnogràfica comparativa de dues residències de persones grans ubicades en contextos socioeconòmics diferents, amb un objectiu determinat, el qual és analitzar si existeixen diferències en el grau d'autonomia i en la preservació de la identitat dels residents segons el barri on s'ubica la institució.

A partir de diferents formes d'observació, així com el registre de les dinàmiques quotidianes, s'examinaran aspectes com l'organització dels horaris, la flexibilitat normativa, la ràtio de personal, la possibilitat de personalitzar els espais (habitacions i objectes personals), l'oferta d'activitats i el grau d'accés a l'exterior. També s'observaran les formes d'interacció entre residents i personal, els espais de decisió individual i les pràctiques que poden reforçar o limitar l'autonomia.

2. Escenaris

Hem decidit fer dos escenaris en diferents localitats: Sant Cugat del Vallès i Barcelona. Volem investigar dues residències: una més cara i amb més recursos en un bon barri de Sant Cugat i l'altre més barat i amb menys recursos d'un barri amb un nivell baix de renda a Barcelona.

Escenari 1 → **Amavir Sant Cugat del Vallès.** Es troba a Carrer de Víctor Hugo, 10, Sant Cugat del Vallès. El telèfon de contacte és: +34 935 836 100
Aquesta residència és una de les més cares de Sant Cugat i disposa d'instal·lacions i serveis d'alta gamma. Té unitats especialitzades, gimnàs, perruqueria, activitats socials, dietes personalitzades i habitacions adaptades amb domòtica assistencial.

Escenari 2 → **Mussol, barcelona** . Es troba a Carrer Bruc,32. El telèfon de contacte és: +34 93 412 53 93
Aquesta residència és publica i per tant més senzilla i ofereix unes instal·lacions amb menys recursos, ja que el preu canvia molt comparat amb l'anterior. L'atenció medica és més bàsica i tot i que també hi ha supervisió 24h, no té els mateixos avantatges que l'anterior.

Amb aquests dos escenaris volem comprovar quines són les diferències entre una residència cara i amb més recursos en un bon barri comparat amb la segona residencia que és més barata i senzilla. El nivell socioeconòmic varia molt entre els dos escenaris i amb el treball de camp volem veure aquestes diferències i analitzar si les suposicions són certes o no.

El treball de camp el farem les quatre integrants del grup i ho farem dividint les 8h en 4 parts. (2 dies al primer escenari - 2h cada dia i els altres 2 dies al segon escenari - 2h cada dia). En total són 4h per cada escenari.

3. Pregunta inicial

La pregunta inicial és la següent:

"¿Quines diferències existeixen en l'autonomia i identitat dels residents segons el context socioeconòmic del barri on es troba la residència?"

La nostra pregunta de recerca és pertinent perquè ens permet examinar fins a quin punt el context socioeconòmic condiciona en l'experiència de la vellesa institucionalitzada. Encara que les residències de persones grans tenen una mateixa funció assistencial, no totes funcionen amb les mateixes condicions materials ni organitzatives. Per això, és necessari preguntar-se si aquestes diferències estructurals impliquen desigualtats en l'autonomia i en la preservació de la identitat dels residents

En conclusió, la pregunta és rellevant perquè relaciona estructura social, organització institucional i identitat, posant en evidència possibles desigualtats en l'envelliment dins del sistema residencial.

4. Suposicions

A partir del concepte d'institució total elaborat per Erving Goffman, hem plantejat la hipòtesi que el nivell socioeconòmic del barri on es troba una residència de persones grans afecta el grau d'institucionalització de la vida quotidiana i, per tant, el nivell d'autonomia i la preservació de la identitat dels residents,

Amb aquest estudi qualitatiu comparatiu volem examinar dues residències de persones grans que es troben en contextos socioeconòmics diferents, on un barri té un nivell alt de renda i l'altre barri un nivell més baix. Aquest estudi té com a objectiu analitzar com el context material i organitzatiu condiciona en la configuració de l'autonomia i la identitat en la vellesa institucionalitzada.

Entenem el grau d'institucionalització a través del model d'institució total com a espais on la vida es produeix sota una autoritat única, amb una separació del món exterior, processos de "mortificació del jo" i amb rutines estandarditzades. Aquesta dimensió conceptual la relacionem amb una dimensió empírica observable com ara la disponibilitat de recursos (flexibilitat horària, oferta d'activitats, accés a l'exterior, ràtio del personal, possibilitat de personalitzar l'habitació).

Nosaltres creiem que la residència situada en un barri socioeconòmicament desfavorit, amb menys recursos humans i materials, s'utilitza una organització més rígida, amb horaris fixos per menjar i higiene, activitats homogènies, espais compartits amb poca personalització i supervisió constant. En aquest cas, la residència "pobra" es presenta com el model ideal d'institució total, ja que l'escassetat de recursos és com un mecanisme de tancament que magnífica la uniformització i accelera la mortificació del jo. Aquesta rigidesa organitzativa es

tradueix en una estructura que borra el passat de les persones i crea una identitat col·lectiva de residents.

En canvi, dins l'escenari de la residència rica, el més probable és que disposi de més personal, habitacions individuals, objectes personals decoratius, activitats diferenciades i major flexibilitat dins les normatives. En aquest context, els recursos

de les famílies funcionen com un dispositiu de desinstitucionalització, és a dir, que es creu que actuarà com una protecció que facilitza que els avis no sentin tant l'impacte d'endinsar-se dins una institució total. D'aquesta manera, la residència "rica" és com una llar assistida més que com una institució total, mantenint viva la identitat de la persona enfront de les normes estrictes del centre.

Si analitzem les idees prèvies, la nostra hipòtesi connecta tres punts. Pressuposem que el nivell socioeconòmic del context (variable estructural) s'associa amb el grau d'institucionalització (variable organitzativa), i aquest amb el nivell d'autonomia i preservació de la identitat (variables subjectives). Així, ho plantegem com una reacció en cadena, on A és com B, l'escassetat de recursos es tradueix en una institucionalització més rígida, i aquesta rigidesa acaba retallant l'autonomia dels avis. De la mateixa manera, si hi ha més recursos, l'organització es pot permetre ser més laxa, facilitant que la persona mantingui el seu "jo" intacte.

Com a conclusió, el que volem demostrar és que les diferències entre les dues residències van més enllà dels diners o les instal·lacions, sinó que van més enllà del que és material, en les formes d'experiència subjectiva. El context socioeconòmic no només determina les infraestructures, sinó que determina si la residència s'apropa a una institució total, rígida i tancada, o, per contra, permet mantenir l'autonomia i la identitat, malgrat la vellesa.

5. Cronograma

(Veure al excel)

Propuesta para marco teorico:

1. Goffman:

1.1 La Institución Total

Vuestro pilar central. Debéis definir qué es una institución total: un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad, comparten una rutina administrada formalmente.

- La ruptura de barreras: En la vida civil, dormimos, jugamos y trabajamos en lugares distintos, con diferentes personas y bajo diferentes autoridades. En la residencia, todo ocurre en el mismo lugar bajo una autoridad única.
- La "Mortificación del Yo" (Mortification of Self): Es el proceso mediante el cual el nuevo interno es despojado de su identidad previa.
    - *En vuestro trabajo:* Analizad si la falta de objetos personales (en la residencia de Ciutat Vella) o la ropa estandarizada acelera esta pérdida de identidad.
- El Sistema de Privilegios: Goffman explica que la obediencia se consigue a cambio de pequeños permisos.
    - *En vuestro trabajo:* ¿Es la "autonomía" en Sant Cugat un derecho o un "privilegio" que se compra?
- Carreras morales

1.2. La Identidad y la "Fachada Personal"

Para hablar de la preservación de la identidad, necesitáis este concepto también de Goffman (*La presentación de la persona en la vida cotidiana*):

- La Fachada Personal: Se compone del lenguaje, el vestido, las poses y los objetos que nos rodean.
- La personalización del espacio: En vuestra hipótesis, la residencia de Sant Cugat permite mantener la "fachada" (muebles propios, fotos, ropa de marca), mientras que en la de Barcelona, la falta de espacio personal obliga a una identidad colectiva (el "abuelo" como categoría genérica).

3. Michel Foucault: Espacialidad y Poder

Para reforzar el análisis de la diferencia entre barrios, os vendría bien mencionar brevemente la microfísica del poder.

- La vigilancia: En residencias con menos personal (Barcelona), la vigilancia suele ser más panóptica (todos a la vista en una sala común para que una sola auxiliar los vea a todos).
- La disciplina del tiempo: Foucault habla de cómo el control del tiempo (horarios rígidos de comida/baño) es una forma de ejercer poder sobre el cuerpo. Vuestra

tesis de que la escasez de recursos obliga a una mayor rigidez horaria encaja perfectamente aquí.

4. Vincent Vincent : Envejecimiento y Clase Social

Para justificar por qué comparáis barrios, necesitáis la Economía Política del Envejecimiento:

- La desigualdad estructural: El envejecimiento no es igual para todos; está atravesado por la clase social.
- La "Dependencia Estructurada": Townsend argumenta que la pérdida de autonomía no es solo biológica (por la edad), sino creada por las instituciones y las políticas que retiran el poder de decisión a los ancianos.

5. Robert Sommer: "Espacio Sociopeto" vs. "Espacio Sociofugo"

Este autor es clave para vuestra observación de las salas comunes. Sommer estudia cómo el diseño físico influye en la interacción social.

- **Espacio Sociofugo:** Son diseños que mantienen a las personas separadas o mirando hacia afuera (como las sillas en fila en una sala de espera o frente a una tele). Esto desincentiva la interacción y fomenta el aislamiento.
    - *Hipótesis:* Quizás en la residencia de Ciutat Vella, por falta de espacio o personal, el diseño sea sociofugo para facilitar la vigilancia.
- **Espacio Sociopeto:** Diseños que favorecen el contacto visual y la conversación (mesas redondas, sofás enfrentados).
    - *Hipótesis:* En Sant Cugat, al haber más recursos, pueden permitirse crear espacios que inviten a la convivencia real.

6. Marc Augé: El "No-Lugar"

Augé define los **no-lugares** como espacios de transitoriedad (aeropuertos, hoteles, hospitales) donde nadie se siente "en casa" y donde no hay historia ni identidad personal.

- **En vuestro trabajo:** Podéis analizar si la residencia más humilde funciona como un "no-lugar" (un sitio de paso, aséptico, donde los residentes son números) frente a la residencia de Sant Cugat, que intenta construirse como un **"Lugar"** (con significado, memoria y personalización).
    - de los lugares a los no lugares
    - el lugar antropologico

1. Peter Townsend: El puente entre Goffman y las residencias

Si Goffman habla de manicomios y cárceles, **Townsend** es quien llevó esa teoría específicamente al mundo de las residencias de ancianos con su obra *The Last Refuge*.

- **Por qué incluirlo:** Él acuñó el concepto de **"Dependencia Estructurada"**.
- **Cómo ayuda a vuestro trabajo:** Townsend argumenta que la pérdida de autonomía no es algo que "venga con la edad" (biológico), sino que la propia institución (por falta de recursos o exceso de control) **fabrica** personas dependientes. Es perfecto para vuestra hipótesis de que en la residencia humilde la dependencia está más "estructurada" por la falta de personal.

2. Pierre Bourdieu: Para explicar la diferencia Sant Cugat vs. Barcelona

Vuestro trabajo tiene una base de clase social muy fuerte. **Bourdieu** es el autor que explica cómo el dinero se transforma en identidad.

- **Concepto clave:** *Capital Económico y Capital Cultural*.
- **Cómo ayuda a vuestro trabajo:** En Sant Cugat, los residentes tienen un capital que les permite "comprar" su identidad (pagar por una habitación individual para poner sus cuadros, sus libros, su ropa).
- **La distinción:** Bourdieu os sirve para analizar cómo el entorno de lujo en Sant Cugat funciona como una **estrategia de distinción**: allí no son "abuelos", siguen siendo "señores/as con estatus". En cambio, en Ciutat Vella, la falta de capital genera una **homogeneización** (todos son iguales ante la institución).

Referencias teóricas Júlia:

Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates

Erving Goffman (1961).

Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Anchor Books.

Es una obra fundamental para entender el concepto de “institución total”, muy útil para analizar cómo las instituciones (como residencias) pueden estructurar la vida diaria y afectar la identidad, autonomía y roles sociales de los residentes.

Katie Paddock, Christine Brown Wilson, Catherine Walshe & Chris Todd (2019).

Care Home Life and Identity: A Qualitative Case Study. The Gerontologist.

- Estudia cómo vivir en una residencia afecta a la identidad y la autonomía de los residentes mediante entrevistas y 260 horas de observación en varias residencias.

- Muestra que las rutinas institucionales y limitaciones organizativas pueden restringir la expresión de la identidad personal de los residente

Peter Townsend (1962).

The Last Refuge: A Survey of Residential Institutions and Homes for the Aged in England and Wales. London: Routledge.

Es uno de los primeros estudios sociológicos importantes sobre residencias de mayores.

Analiza cómo las instituciones afectan a:

- la vida cotidiana de los residentes
- su autonomía
- las relaciones sociales dentro de la residencia

Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1966).

The Social Construction of Reality. New York: Anchor Books.

Texto fundamental de sociología del conocimiento que explica cómo la realidad social y las identidades se construyen a través de las interacciones y las instituciones, muy útil para interpretar etnográficamente la vida en residencias.

Mette Andresen & Lis Puggaard (2008).

Autonomy among Physically Frail Older People in Nursing Home Settings.

- Analiza cómo los residentes perciben su autonomía en la vida diaria dentro de las residencias.
- Destaca que la falta de control sobre las actividades cotidianas puede afectar negativamente al bienestar físico y mental

REFERENICAS TEORICAS

Te explico **de forma breve de qué trata cada lectura de Blanca Valdivia y cómo se relaciona con un estudio de observación en residencias de mayores.**

1. *Recursos urbans de suport a les cures als municipis de Barcelona* (2024)

De qué va (resumen):
Este estudio analiza **qué recursos urbanos ayudan a sostener las tareas de cuidado** en las ciudades (servicios sociales, equipamientos, transporte, espacios públicos, redes comunitarias, etc.). La idea central es que el cuidado no ocurre solo en el hogar o en instituciones, sino que **depende también del entorno urbano y de los servicios disponibles**. (diba.cat)

El trabajo identifica las **condiciones materiales e infraestructuras** que facilitan cuidar:

- centros de día, residencias, servicios sociales
- transporte accesible
- proximidad de servicios
- espacios públicos adaptados (bancos, sombras, accesibilidad) (cuimpb.cat)

Relación con vuestro estudio en residencias:
Sirve para entender que una residencia **no funciona aislada**, sino dentro de un **ecosistema de cuidados**. En la observación podéis fijaros en:

- relación entre residencia y barrio
- visitas familiares y redes externas
- conexión con servicios sanitarios o comunitarios
- accesibilidad del entorno

---

2. *Territorios cuidadores. La propuesta de la bioregión desde la dimensión de los cuidados* (2023)

De qué va (resumen):
Este capítulo propone pensar el cuidado **a escala territorial** (no solo en la casa o en una institución). Habla de **"territorios cuidadores"**, es decir, territorios organizados para sostener la vida mediante redes de servicios, comunidades y recursos.

La idea es que el cuidado debe organizarse **de forma colectiva y territorial**, no solo individual o familiar. (Crític)

Incluye temas como:

- redes de servicios públicos
- organización territorial del cuidado
- relación entre comunidad, instituciones y entorno
- sostenibilidad social y ecológica

Relación con vuestro estudio en residencias:
Permite analizar la residencia como **una pieza dentro del sistema territorial de cuidados**.

En la observación podéis mirar:

- cómo se conecta la residencia con el sistema de bienestar
- relación con familias, servicios sanitarios y comunidad
- papel de la residencia dentro de la red de cuidados del territorio

---

3. *Ciudades que cuidan: transformar el espacio para priorizar la vida* (2022)

De qué va (resumen):
Este texto introduce el concepto de **"ciudad cuidadora"**: una ciudad diseñada para **priorizar la sostenibilidad de la vida y las necesidades de cuidado**.

Desde el urbanismo feminista se plantea que las ciudades tradicionales se han diseñado pensando en el trabajo productivo (movilidad trabajo-casa), pero **no en las actividades de cuidado**. (Barcelona.cat)

Por eso propone repensar el urbanismo para facilitar:

- cuidado de personas mayores
- movilidad accesible
- proximidad de servicios
- espacios comunitarios y redes de apoyo

Relación con vuestro estudio en residencias:
Ayuda a entender cómo el **espacio físico influye en el cuidado**.

En la observación podéis fijaros en:

- diseño de los espacios de la residencia
- accesibilidad y movilidad interior
- espacios de socialización
- cómo el espacio facilita o limita el cuidado

Para un **trabajo de observación en residencias**, la que **mejor encaja directamente** es:

1️⃣ Blanca Valdivia – *Recursos urbans de suport a les cures als municipis de Barcelona* (2024)

Por qué es la más útil:

- Analiza **infraestructuras y servicios de cuidado** en el territorio (residencias, centros de día, servicios sociales, etc.).
- Habla de **cómo se organizan los cuidados en los municipios**, algo que conecta directamente con las residencias.
- Permite situar la residencia dentro de un **ecosistema de cuidados** (familia, servicios públicos, comunidad).

Cómo os sirve para el trabajo de observación:

Podéis usarla para explicar:

- qué papel tienen las **residencias dentro del sistema de cuidados**
- cómo se relacionan con **otros recursos del territorio**
- cómo las políticas públicas organizan el cuidado de las personas mayores

---

2️⃣ Segunda más útil

Ciudades que cuidan: transformar el espacio para priorizar la vida (2022)

Esta también puede servir bastante porque habla de **cómo el espacio influye en el cuidado**.

Os puede ayudar a observar:

- cómo están diseñados los espacios de la residencia
- si facilitan la autonomía o la interacción
- cómo se organizan los espacios comunes

Pero es **más urbanística y general**, no tan centrada en residencias.

3️⃣ La menos directa para vuestro trabajo

Territorios cuidadores. La propuesta de la bioregión desde la dimensión de los cuidados (2023)

- Es más **teórica y a escala territorial grande** (bioregiones).
- Habla de redes de cuidado y sostenibilidad territorial.
- Sirve más para **marco conceptual amplio**, pero menos para observación concreta en una residencia.

✅ **Conclusión clara para vuestro trabajo:**

1. **Mejor:** *Recursos urbans de suport a les cures…* (2024)
2. **También útil:** *Ciudades que cuidan…* (2022)
3. **Más teórica:** *Territorios cuidadores…* (2023)

Una **referencia sociológica muy adecuada para vuestro trabajo** (porque trata específicamente **género y trabajo en residencias**) es esta:

Referencia recomendada

Sandra López Fernández, Paloma Candela Soto y María del Carmen Sánchez Pérez (2022)
Residencias de Mayores: un sector feminizado donde mandan, cada vez más, los hombres, en la revista *Sociología del Trabajo*.

De qué trata (resumen)

El artículo analiza **la división sexual del trabajo en las residencias de mayores en España**. Parte de la idea de que el sector de los cuidados es **fuertemente feminizado**, pero existe una **segregación de género en los puestos de trabajo**. (revistas.ucm.es)

Los resultados muestran que:

- **Más del 80 % de las personas que trabajan en residencias son mujeres.** (revistas.ucm.es)
- Sin embargo, **los puestos de dirección, gestión o mayor poder suelen estar ocupados por hombres.** (revistas.ucm.es)
- Las mujeres se concentran sobre todo en **puestos de cuidado directo** (auxiliares, gerocultoras), que son **menos valorados y peor pagados**.

Esta situación refleja una **segregación ocupacional de género**, típica de los sectores de cuidados.

Qué datos generales del sector muestran esta feminización

En España, el trabajo en residencias está claramente feminizado: **alrededor del 86 % del personal en residencias de mayores son mujeres**. (El País)

Esto confirma que el cuidado institucional también reproduce la **división sexual del trabajo**.

Por qué esta referencia encaja con vuestro trabajo de observación

Os ayuda a interpretar lo que observéis en la residencia, por ejemplo:

- **Quién realiza el cuidado directo** (aseo, movilización, acompañamiento).
- **Quién ocupa los puestos de autoridad** (dirección, coordinación).
- Diferencias entre **trabajo emocional y trabajo organizativo**.
- Cómo se reproduce la idea de que **cuidar es "trabajo de mujeres"**.

Es decir, os da un **marco sociológico de género** para analizar la organización del trabajo dentro de la residencia.

✅ **Cómo podríais citarla en el trabajo (idea breve):**
Podéis decir que el sector residencial forma parte de la **economía del cuidado**, caracterizada por una fuerte feminización laboral y por una división sexual del trabajo que sitúa a las mujeres en los puestos de cuidado directo mientras los hombres ocupan con mayor frecuencia posiciones de poder organizativo.

Una **referencia catalana muy buena para vuestro trabajo**, y además publicada en una revista de sociología de la **Universitat Autònoma de Barcelona**, es esta:

Referencia

Dolores Meseguer Chanzá (2024)
Papers. Revista de Sociologia –
"Segregación laboral en actividades feminizadas: los servicios residenciales de atención a las personas mayores." (papers.uab.cat)

De qué trata (resumen)

El artículo analiza **cómo funciona la segregación de género en el trabajo de las residencias de mayores**, es decir, cómo hombres y mujeres se distribuyen de forma desigual en los distintos puestos del sector. (papers.uab.cat)

Las ideas principales del estudio son:

- Las residencias forman parte de un **sector muy feminizado** (la mayoría del personal son mujeres).
- Las mujeres suelen ocupar **puestos de cuidado directo** (auxiliares, gerocultoras, atención cotidiana).
- Los hombres aparecen con más frecuencia en **puestos de dirección, gestión o mantenimiento**.
- Esto reproduce una **división sexual del trabajo**, donde el cuidado se considera una tarea "femenina".

Por qué encaja muy bien con vuestro trabajo de observación

Esta referencia os sirve para **interpretar sociológicamente lo que observéis en la residencia**, por ejemplo:

1. Distribución de tareas

- quién hace el cuidado directo (aseo, movilización, acompañamiento)

2. Jerarquías laborales

- quién dirige o coordina el trabajo

3. Valoración del trabajo

- qué tareas son más visibles o valoradas

4. Feminización del cuidado

- por qué la mayoría del personal son mujeres

✅ **Cómo podríais usarla en el trabajo (idea breve):**

Podéis decir que el trabajo en residencias forma parte de los **sectores feminizados de la economía del cuidado**, donde existe una **segregación ocupacional de género** que sitúa a las mujeres en tareas de cuidado directo y a los hombres con mayor presencia en puestos de gestión o autoridad.

Otra referencia **muy citada en sociología del envejecimiento** que utiliza ideas de **Michel Foucault** y que encaja muy bien con estudios sobre residencias es esta:

Referencia

Amanda Grenier (2007)
"The Constructions of Frailty in Old Age: Narratives of the Third and Fourth Age."
Publicado en *Ageing & Society*.

De qué trata (resumen)

El artículo analiza **cómo se construye socialmente la "fragilidad" en la vejez**. Grenier muestra que la sociedad clasifica a las personas mayores en dos grandes categorías:

- **Tercera edad** → personas mayores activas, autónomas, saludables.
- **Cuarta edad** → personas consideradas dependientes o frágiles.

Usando ideas de **Michel Foucault**, explica que estas categorías no son solo médicas, sino también **formas de organizar y controlar el envejecimiento** mediante discursos profesionales, instituciones y políticas sociales.

Ideas clave del artículo

1. Construcción social de la fragilidad
La "fragilidad" no es solo física, también es una **etiqueta social**.

2. Poder del discurso experto
Profesionales (médicos, trabajadores sociales, gerontólogos) definen quién es autónomo o dependiente.

3. Gestión institucional de la vejez
Instituciones como residencias organizan la vida de quienes se consideran más dependientes.

Cómo os sirve para vuestro trabajo de observación

Esta perspectiva os ayuda a observar cosas como:

Clasificación de residentes

- quién es considerado más autónomo o más dependiente

Lenguaje del personal

- cómo hablan sobre los residentes (“válidos”, “dependientes”, etc.)

Organización del cuidado

- diferencias en atención según nivel de dependencia

Relaciones de poder

- quién decide sobre la vida cotidiana de los residentes

✅ **Idea que podéis usar en el trabajo:**
Desde una perspectiva foucaultiana, las categorías de autonomía, dependencia o fragilidad forman parte de **discursos institucionales que organizan el cuidado y la gestión del envejecimiento en instituciones como las residencias**.

Entrevista

ITEMS:
sancu privsada:

1. la recepcion es bastante amplia, hay mucha luz, el mostrador también es amplio
2. hay mucha gente en el comedor
3. la residencia esta a una temperatura bastante buena
4. el lugar luce de muy buena calidad y constantemente hay gente preguntando a los abuelos si necesitan algo, hay muchas salas y parece que tienen muchos servicios
5. en la sala hay muchas fotos y colores, juegos de mesa.
6. abuelos hablan de sus vivencias: “que tiempos aquellos, ojala poder volver a esos tiempos”
7. conversacion entre dos abuelos: “creo que me estoy empezando a olvidar de las cosas”
8. conversación chico-abuelo: “sin prisas eh chaval”, “tendremos que ver cuando llegues a mi edad” - risas
9. se escuchan bastantes risas e interacciones.
10. conversacion mujer-julia: “todos los jovenes deberian venir a ver la realidad de la vida y de como todos acabamos aqui, los mas ricos y los mas pobres”
11. casi todo son mujeres, solo dos hombres en la actividad. Más abuelas que abuelos en la residencia
12. sala amplia con juegos
13. muchas sillas de ruedas
14. conversación: una mujer mayor dice que no se tomara la pastilla , que ya no le hace falta y la enfermera le dice que se alegra
15. Juegan al domino
16. casi todos hablan es castellano, excepto la Xenia i algún abuelo
17. Todo el personal esta vestido con un unforme y casi todos llevan bata
18. conversación: a una señora se le cae el pendiente i la otra lo recoge “el pendiente de la Lola Flores “dice, y ríe. La otra se ríe ya dice “sisisi y cuesta mucho dinero. Ríen y dice “lo se lo se”
19. muchas de las señoras tienen el pelo teñido de castaño, rubio o pelirrojo. Casi todas llevan pendientes, bien vestidas con jerséis y camisas.
20. Hay tres plantas de residentes, como gimnasio que solo pueden utilizar acompañado, biblioteca que la utilizan mas en invierno, cafetería, comedor, todo parece un laberinto
21. salen al jardín pasar tomar el sol y escuchan musica
22. Los que mas hablan son los únicos tres hombres y una mujer con gafas y camisa de leopardo.
23. muchas ventanas, gran iluminación
24. mucha comunicación entre la trabajadora social y los abuelos
25. abuela con gafas de sol
26. silla de ruedas electrica
27. la xénia dirige la clase, manda a callar una disputa
28. ambiente bromista
29. Mucha gente
30. van cambiando el idioma de catalan a castellano
31. chica de acompañamiento que hace fotos
32. mucha mimica, los abuelos hablan poco, pero se expresan moviendo la cabeza
33. remarcan todo lo que ven mal, si alguien no escucha o si se equivoca.
34. preocupación por el medio ambiente

35. curiosidad por lo que hacemos
36. los trabajadores vigilan mucho a los residentes para procurar que jueguen bien
37. mucha animación si alguien hace algo bien.
38. mucha broma entre los internos “la xénia le da con la silla a la elena y le cae el movil: -vamos para bingo-”
39. tienen juegos para jugar a los dardos
40. los que ganan reparten los caramelos con los compañeros
41. cada vez que acaba una interacción aplauden.
42. muchas conversaciones paralelas de como ha ido el bingo.
43. para despedirse se despiden con besos i se van
44. las trabajadoras recogen la actividad y ajudan a limpiar los cartones.
45. la xenia pregunta pregunta si necesita algo más. le deja hacer fotos del recinto. mucha dipsoición.
46. llaman a la xénia por telefono (tienen todos los trabajadores un telefono consigo)
47. tienen terraza
48. la xénia esta despistada y cansada en algunos momentos, le caen los papeles al suelo.
49. tres plantas a la residencia de diferentes colores
50. la naranja, la tercera, es donde estan los autònomos. la azul, son los más dependientes.
51. estan divididos de 30 en 30, con una sala de estar y comedor individual.
52. en la cafeteria hay familiares visitando a los abuelos.
53. algunos abuelos le sonrien sin saber quien es, pero otros ni se mueven
54. la xénia comenta que es dificil ver como los abuelos se van deteriorando
55. los abuelos preguntan mucho
56. un abuelo dice que cree conocerla
57. reunión de abuelas, hablan de lo que paśo ayer por la noche, en la planta de abajo del todo. hay mucho movimiento en la planta baja. espacio acogedor
58. un olor caracteristico a personas majores,
59. mucha gente paseando con sus familiares
60. la recepcionista saluda a las abuelas “hasdta luego guappa”.
61. sala propia para el personal
62. tiene un menú en la cafeteria
63. un los abuelos sex
64. losas ab yuelas hablan flojo, cuesta escucharlas. a la planta baja se juntan dos grupos de amigas, unas juegan alfdominó, otras van en sillas de ruedas “voy a ver a las compis”
65. l acercan a preguntar cosas a la recepcionista. muchos abuelos intentan iniciar conversaciones
66. los trabajadores dicen muchos cumplidos a los residentes
67. las abuelas llevan vestidos
68. horarios estructors para desayunos, comer, merendar y cenar. los colores son caliudos.
69. se escucha musica desde la cafeteria
70. hay señoras de la limpieza.
71. algunos abuelos no se toman bien que estemos observando, miraja desafiante.
72. mucha decoración
73. la actividad del, psicologo es en castellano, a algunos abuelos les cuesta.

74. Casi todas los trabajadores son mujeres y varias
75. se nota que muchas tienen dinero por su vestimenta y su forma de hablar
76. la xenia y el psicólogo llevan bata pero con su ropa de calle debajo, en cambio las enfermeras van con el uniforme y mas dejadas
77. una bauekla pide disculpas al psicologo proque estabadescaida, prowque se ha enfadado porque no le han dejado la hbaitación como queria
78. uno de los ancianos para el trabajo del camarero para hablar con él
79. se sientan en forma de U
80. el fisio mueve las sillas para que pasen aunque lleguen tarde
81. personal de la residencia pública latineomericana o joven.
82. Las salas tienen mucha luz natural
83. Acostumbran a contestar al fisio las mismas personas
84. Hay personas dormidas en las sillas mientras se hace clase de fisio
85. El personal de cocina pasa por la sala constantemente e interactua con algunos pacientes
86. Cuando los pacientes responden a las preguntas que hace el fisio, él les va animando “muy bien”, “quién ha dicho esto? Muy bien dicho” “genial”
87. En clase de psicomotricidad no hablan entre ellos, hay mucha concentración
88. Se escuchan suspiros y gestos de cansancio
89. Al acabar la clase se acercan para hablar entre las que son más amigas. Una de ellas le dice a otra “cada día estás más guapa, Mari”
90. En la sala de estar, una mujer se sienta y se queja de que le quitaron su sitio, comienza a hablar del resto de pacientes que hay en la sala
91. Los trabajadores se van llevando a los pacientes de la sala de estar al comedor
92. Hablan por los pasillos con los trabajadores. “Juana, cómo va? Ha venido tu hijo a verte?”
93. Una de las pacientes se ha perdido y no sabe en qué planta está, la trabajadora le acompaña a su habitación
94. Entran en otra habitación de al lado y miran la nevera que tiene el paciente. Es de los pocos que le permiten tener una mini nevera en su habitación porque puede gestionar un poco de comida
95. En la cafetería se oye ruido de las conversaciones
96. El camarero se lleva bien con los pacientes
97. El camarero para de hacer lo que estaba haciendo para hablar con un paciente
98. En la recepción hay pacientes sentados observando
99. La recepcionista saluda a los pacientes cariñosamente
100.

Privada y publica.

101. camaras de vigilancia en la pública, zonas privadas a la vista de todos. poca interaccion entre los residentes.
102. la residencia privada esta apoartada con un carteyl grande, esat periferia, vegetación, parking, mucha vegetación.
103. la residencia publica esta en un edificio, comparte lugar con vecinos y cuesta encontrarla. esta centrica.
104. habitaciones compartidas en la residencia pública.
105. no suficiente personal. cuando una abuela intenta levantarse la obsercadora tiene que levantarse para ayudarla, posteriormente aparecen los trabajadores.

106. en la pública todos visten en chandal o repoa comoda.
107. en la pública poca vigilancia, me tengo que levantar para ayudar a uno de los señore.s
108. en la residencia privada, las plantas estan bien separadas, tienen gimnasio, actividades, zonas de descascnso, y abajo con su bar donde se reunen las amigas.
109. en la residencia privada no hya casi interaccion o amistad entre residentes, pues todos estan juntos, y conviven los muy deteriorados con los mas activos.
110. en la privada los temas principales de conevrsación son las casas o familias.
111. las enfermeras en la pública son mujeres jovenes, o latinoamericanas.
112. en la publica, en la cocina veo al trabajador con el movil.
113. en la pública, durante varios minutos un señor no para de decir me muero, me morire, me voy a morir.
114. el trabajador latinoamericano les habla coin mucho cariño “vale cariño esperame, de acuerdo”, y intenta sacar conversación con algunos”tu madre no te deja tener novio?
115. en la privada dice una abuela, tengo alegria cuando salgo de casa.
116. mientras hacemos una actividad en la privada, entra una señora latinoamericana a dar zumo, va pregutnando cual le apetece más.
117. la rosa en la privada quiere pexdir cita para hacerse el bigote en la peluqueria. todas las abuelas van teñiidas.
118. en la privada hya una pelea entre abuelas, “guarra” “maleducada·”, la trabajadora va rapido a solucionar la situación .
119. EN la privada hay personal de limpieza limpiando contantmente
120. EN ls pública tiran las sabamnas al suelo, al cabo del rato viene otra persona a meterlas en la secadora, quen esta dentro de un armario en la terraza.
121. La pública comparte edificio con vecinas y se las ve cuando pasan por las escaleras.
122. unas abuelas en la privada hbalan de sus hijos “ami mi hijo me ha traido mermelada”

publica:

123. la residencia publica es un piso de barcelona acondicionado.
124. en la residencia publica hay un hombre que pide otro cigarro. pero el trabajador le dice que ya le ha encendido uno.
125. la cocian, el patio, el comedor y el despacho estan conectados, todo con puertas de cristal en la publica.
126. tras atender a los abuelos el trabajador se sienta en el banco al aldo de manolo a mirar videos.
127. todos llevan uniforme, sara la directoira, comenta que guardan su ropa en una habitación pequeña, habitacion estrecha con dos armarios y taquillas para guardar tanto la ropa de los trabajadores como la de los abuelos.
128. el trabajador despues de un rato en la cocina entra con vasos de té, hace tres viajes para traerlos todos, y además le da con cuchara el té a los que no pueden moverse-.

ESTOY EN análisis cualitativo, entonces necesito que a partir de los indicadores que te voy a poner ahorra, hagas sus respectivas dimensiones y a su vez lo agrupes en conceptos . Tal y como lo hacen el en power q te proporciono en las tablas. Además hazlo con conceptos teóricos que te voy a prorpiconar y teniendo en cuenta que es un trabajo de la comparación de dos residencias que una es publica y otra privada , donde nuestra pregunta de investigación es si dependiendo de los recursos de una residencia (Publico, privada) condiciona la autonomía e identidad de los residentes. También te pongo el trabajo que llevamos oara que tengas mas contexto . A continuación te pongo los indicadores que habíamos hecho nosotras de solo Sant Cugat , a partir de ellos haz las dimensiones y sus conceptos Teóricos:

CONCEPTOS TEÓRICOS	DIMENSIONES	SUBINDICADORES	INDICADORES LITERALES (Sant Cugat / Barcelona)
I. EL ECOSISTEMA DE CUIDADOS (Blanca Valdivia / Marc Augé)	**A. Del "Lugar" al "No-lugar"**	**Sentido del entorno**	• **Privada (Lugar):** "muchas fotos y colores", "espacio acogedor", "recepción amplia, mucha luz". • **Pública (No-lugar):** "habitaciones compartidas", "puertas de cristal", "pasillos estrechos".
	B. Conexión Territorial	**Relación barrio-residencia**	• **Privada:** "apartada... periferia, vegetación, parking". • **Pública:** "comparte lugar con vecinos... céntrica".

II. DIVISIÓN INTERSECCIONAL DEL TRABAJO (Evelyn Nakano Glenn / Meseguer)	**A. Segregación Vertical y Etnia**	**Jerarquía y Cadenas de Cuidado**	• **Privada:** "psicólogo con ropa de calle bajo la bata", "señora latinoamericana da zumo". • **Pública:** "enfermeras latinoamericanas o jovenes", "uniforme y mas dejadas".
III. RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD RESIDENCIAL (Fina Antón / Goffman)	**A. La "Fachada Personal" y el Estatus**	**Cuidado de la imagen y distinción**	• **Privada:** "pelo teñido", "pendientes", "vestidas con jerséis y camisas", "cita peluqueria bigote". • **Pública:** "visten en chandal o repoa comoda", "tiran las sabanas al suelo".

	B. Pertenencia y Desposesión	**Objetos personales y espacio propio**	• **Privada:** "se ha enfadado porque no le han dejado la hbaitación como queria", "le traen mermelada". • **Pública:** "guardan su ropa en una habitación pequeña... taquillas".
IV. AUTONOMÍA RELACIONAL Y PODER DE DECISIÓN (Enid Schatz / Townsend)	**A. Agencia frente a Dependencia**	**Capacidad de elección real**	• **Privada:** "poder elegir zumo", "decidir ir a la cafetería", "ganan reparten caramelos". • **Pública:** "trabajador le dice que ya le ha encendido un cigarro" (Control total de la acción).

	B. Microfísica del Control	**Vigilancia vs. Acompañamiento**	• **Privada:** "la xenia dirige la clase", "teléfonos internos", "animación". • **Pública:** "camaras de vigilancia", "no suficiente personal para ayudar a levantarse".
V. GESTIÓN DE LA FRAGILIDAD (Amanda Grenier)	**A. La Cuarta Edad Institucional**	**Visibilidad del deterioro**	• **Privada:** "planta naranja (autónomos) vs azul (dependientes)". • **Pública:** "conviven los muy deteriorados con los mas activos", "señor dice: me voy a morir".

Modelo B: Para el Residente (Lenguaje Sencillo y Cercano)

I. EL ECOSISTEMA DE CUIDADOS

1. ¿Siente que esta es su casa o le parece más un hospital o un hotel?
2. Si quiere ir a dar un paseo a la calle solo, ¿sabe qué tiendas o parques hay cerca?
3. **¿Le gusta cómo está decorada su habitación o le gustaría que fuera de otra manera?**
4. **¿Los pasillos le parecen alegres y con luz, o le resultan un poco fríos y estrechos?**
5. **¿Ve a menudo a gente del barrio (vecinos, niños) paseando por aquí dentro?**

II. DIVISIÓN INTERSECCIONAL DEL TRABAJO

1. **¿Con quién de los que trabajan aquí le gusta más charlar de sus cosas?**
2. **¿Cómo sabe quién es el médico y quién es el que limpia? ¿Por la ropa que llevan?**
3. Las personas que le ayudan a bañarse o a comer, ¿son de aquí o vienen de otros países?
4. **¿Siente que los que le cuidan van siempre con mucha prisa o tienen un ratito para usted?**
5. **¿A quién le pide un favor si necesita algo que no sea una medicina (un vaso de agua, un papel)?**

III. RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD RESIDENCIAL

1. **¿Quién elige la ropa que se pone hoy? ¿Le gusta arreglarse y ponerse sus joyas o colonia?**
2. **¿Qué cosas de su casa de toda la vida se ha traído para que su cuarto sea "suyo"?**
3. ¿Dónde guarda sus cosas más personales para que nadie las toque?
4. ¿Se siente usted "el de la habitación 20" o siente que aquí todos saben bien quién es usted?
5. **¿Cuándo fue la última vez que fue a la peluquería o se arregló el bigote/barba?**

IV. AUTONOMÍA RELACIONAL Y PODER DE DECISIÓN

1. **Si ahora mismo le apetece un caramelo o un zumo, ¿puede cogerlo usted mismo o tiene que pedir permiso?**
2. **¿Siente que le vigilan mucho (con cámaras o personas) o tiene libertad para estar solo?**
3. ¿Puede elegir con quién sentarse a comer o ya le dan el sitio dicho?
4. ¿Le dejan cerrar la puerta de su cuarto o del baño para tener su intimidad?
5. **Si un día no tiene ganas de hacer gimnasia o talleres, ¿qué pasa? ¿le obligan a ir?**
6. **En qué decisiones del menú o de la decoración del centro pueden participar los residentes de forma real?**

V. GESTIÓN DE LA FRAGILIDAD

1. ¿Le gusta estar con compañeros que están muy malitos o prefiere estar con los que están más activos?
2. ¿Qué siente cuando ve que algún compañero ya no viene al comedor porque está peor?
3. ¿Siente que aquí le tratan como a una persona mayor con sabiduría o a veces como a un niño?
4. ¿Se habla aquí de la salud y del futuro o es un tema que nadie quiere tocar?
5. **¿Le separa el personal de los compañeros que necesitan mucha ayuda o están todos mezclados?**
6. **tiene amigos cercanos en la residencia?**

Modelo A: Para el Trabajador (Lenguaje Directo y Operativo)

I. EL ECOSISTEMA DE CUIDADOS

1. ¿Qué hacen para que el centro no parezca una institución fría y sea más acogedor?
2. ¿Tienen actividades donde los vecinos del barrio entren a la residencia habitualmente?
3. **¿Considera que el diseño de los pasillos y salas facilita la convivencia o es puramente funcional?**
4. **¿Cómo de fácil es para un residente salir a la calle a dar un paseo por su cuenta?**
5. **¿Hay rincones en la residencia donde los familiares puedan estar a solas con el residente?**

II. DIVISIÓN INTERSECCIONAL DEL TRABAJO

1. **¿Qué perfil de trabajador (auxiliares, limpieza, cocina) tiene más trato emocional con el residente?**
2. ¿Se nota una diferencia de nacionalidad entre los puestos de oficina y los de cuidado directo?
3. **¿Es obligatorio el uso de uniforme rígido o se permite ropa más "de calle" en algún momento?**
4. ¿Cómo gestionan las quejas de los residentes sobre las tareas de limpieza o comida?
5. **¿Quién asume la tarea de "escuchar" al residente cuando está triste o agobiado?**

III. RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD RESIDENCIAL

1. **¿Tienen límites sobre cuántos muebles o trastos personales puede traer un residente a su cuarto?**
2. **¿Cómo se aseguran de que cada residente mantenga su estilo personal (peinado, ropa, joyas)?**

3. **¿Qué ocurre cuando un residente quiere cambiar la decoración de su cuarto o no le gusta cómo está?**
4. ¿Cómo evitan que la ropa de los residentes se pierda o se confunda con la de otros?
5. **¿Se fomenta que el residente use su propia ropa?**

IV. AUTONOMÍA RELACIONAL Y PODER DE DECISIÓN

1. **¿Qué margen tiene un residente para saltarse el horario de desayuno o de acostarse?**
2. ¿Cómo controlan que los residentes estén bien sin que ellos se sientan vigilados por cámaras?
3. **¿Pueden los residentes elegir libremente a sus compañeros de mesa o de habitación?**
4. **¿Qué protocolos hay si un residente quiere tener algo de comida o bebida propia en su cuarto?**
5. ¿En qué decisiones del centro (menús, fiestas) pueden votar o dar su opinión los residentes?

V. GESTIÓN DE LA FRAGILIDAD

1. **¿Qué impacto tiene en los residentes más autónomos el convivir con personas muy deterioradas?**
2. **¿Cómo se gestiona el duelo o la ausencia de un residente cuando fallece para que no afecte al resto?**
3. **¿Hay espacios separados para los que tienen demencia avanzada o comparten todos las mismas salas?**
4. ¿Cómo se fomenta la visibilidad de los residentes más frágiles sin que se sientan "expuestos"?

¿Te gustaría que te ayude a crear una **hoja de observación** para que, mientras ellos responden, tú puedas anotar detalles visuales (si llevan pendientes, si la habitación tiene fotos, si el pasillo huele a hospital, etc.)?